Anamnesefragen

Was kann ich für Sie tun?
Was führt Sie zu uns?
Wo genau haben Sie diese Schmerzen?
Seit wann haben Sie diese Schmerzen?
Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus?
Haben Sie Brustschmerzen, Luftnot oder ein Engegefühl?
Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten?
Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen, z. B. Belastung oder nach dem Essen?
Was haben Sie gegessen?
Wo haben Sie das gegessen?
Gibt es jemanden, der das gleiche Essen gegessen hat und ähnliche Symptome hat?
Waren Sie deswegen schon einmal bei Ihrem Hausarzt?
Sind die Schmerzen dauerhaft da, oder gehen sie wieder weg?
Ist es das erste Mal, oder hatten Sie schon früher ähnliche Symptome?
Sind die Schmerzen mit der Zeit schlimmer geworden?
Können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Sind die Schmerzen stechend oder dumpf?
Wie stark sind die Schmerzen?
Gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt, z. B. Bewegung, oder etwas, das sie lindert, z. B. Hinlegen?
Haben Sie etwas gegen die Schmerzen genommen?

Wurden Sie schon einmal operiert?

Haben Sie Fieber?
Seit wann?
Haben Sie die Temperatur gemessen?
Wie hoch war sie?
Wo haben Sie gemessen?
Haben Sie Schüttelfrost?
Schwitzen Sie mehr als sonst oder haben Sie Schweißausbrüche bzw. Nachtschweiß?

Ist Ihnen aufgefallen, dass Ihre Haut in der letzten Zeit gelb geworden ist?

Haben Sie Übelkeit oder Erbrechen?
Seit wann?
Wie oft?
Wie sah das Erbrochene aus? Welche Farbe und Konsistenz hatte es?
Gab es Blut im Erbrochenen?

Haben Sie Probleme beim Stuhlgang?
Seit wann?

Wie oft?
Welche Farbe und Konsistenz hat der Stuhl?
Gibt es Blut im Stuhl?

Haben Sie Probleme beim Wasserlassen?
Haben Sie Schmerzen oder Brennen beim Wasserlassen?
Welche Farbe hat der Urin?
Gibt es Blut im Urin?
Haben Sie verstärkten Durst bemerkt?
Wie viel Wasser trinken Sie täglich?

Haben Sie Völlegefühl oder Blähungen?

Leiden Sie unter Sodbrennen, saures Ausstoßen?

Wie ist Ihr Appetit?
Haben Sie in der lezten Zeit Gewicht abgenommen?

Können Sie wegen der Schmerzen schlecht schlafen?
Fühlen Sie sich müde?

Was essen Sie normalerweise? Essen Sie gerne Fleisch, Wurst, Sahne, Käse oder fetthaltige Speisen?

Gibt es andere Beschwerden, die gleichzeitig auftreten?

Am Ende des Gesprachs Aufklarung

Ich habe einen Verdacht auf Bauchspeicheldrüsenentzündung, möglicherweise aufgrund Ihres Alkoholkonsums.
Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen.
Ich werde zuerst körperliche Untersuchung machen, dann Blut für das Labor abnehmen und einen EKG schreiben um eine Herzursache auszuschließen. Danach werde ich eine Bauchultraschall durchführen. Wissen Sie, was das ist?
Sobald die Ergebnisse vorliegen, bespreche ich mit meinem Oberarzt, dann komme ich zu Ihnen, erzähle Ihnen alles

Sonographie – Ultraschall:

Ein Ultraschall des Bauchraums ist eine schmerzfreie und strahlenfreie Untersuchung, die etwa 15 Minuten dauert. Ein Gel wird auf Ihren Bauch aufgetragen und Ihre inneren Organe mit einer Sonde beobachtet. Das ist nicht nur bei Schwanger, wir können damit alle inneren Organe beobachten.

Haben Sie an mich noch Fragen?

ARZT-ARZT GESPRACH

Guten Tag, Herr Oberarzt, Frau Oberärztin.
Mein Name ist Sümeyra Firat. Heute habe ich eine neue Patientin aufgenommen.
Bevor ich meine Patientin vorstelle, möchte ich Ihnen noch etwas Wichtiges mitteilen:
Ich habe einen Anruf aus dem Labor erhalten. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Müller einen Kaliumwert von 2,6 mmol/L hat. Dieser Wert ist deutlich erniedrigt und entspricht einer Hypokaliämie.

Jetzt berichte ich über den Fall meiner Patientin.

Es geht um Herrn Dieter Kazmarek. Er ist 59 Jahre alt, am 31.12.1962 geboren, 183 cm groß und wiegt 74,3 kg.
Er stellt sich bei uns wegen seit zwei bis drei Wochen bestehender Bauchschmerzen im Oberbauch/Epigastrium vor.
Laut Angaben des Patienten sind die Schmerzen postprandial (nach dem Verzehr von Eiersalat mit Brot und Butter) aufgetreten.
Er berichtet, dass die Schmerzen in den Rücken ausstrahlen und die Schmerzintensität bei 5–6/10 auf der Schmerzskala liegt.
Nach Angaben des Patienten sind die Schmerzen kolikartig und ziehend.
Er erwähnt, dass er seit drei Monaten ähnliche Beschwerden hat, die Schmerzen jedoch im Verlauf schlimmer geworden sind.

Begleitend klagt er seit drei Wochen über Nausea und seit zwei Wochen über Diarrhoe, vier bis fünfmal täglich, dünn, hellbraun und glänzend.
Außerdem hat er dunklen Urin und Nachtschweiß.
Vegetativanamnestisch ergaben sich Müdigkeit, Inappetenz, eine Gewichtsabnahme von 5–10 kg in vier bis fünf Wochen und Dyssomnie.
Die Allergie-, Medikamenten- und Vorerkrankungsanamnese waren unauffällig, bis auf einen Clavus.

Er gab an, dass er vor 29 Jahren wegen eines Autounfalls eine Osteosynthese einer rechten Unterschenkelfraktur hatte. Es gab Komplikationen, und er musste Bluttransfusionen erhalten.

Bei der Noxenanamnese erwähnte er 40 py, täglich drei bis vier Flaschen Bier seit 30 Jahren sowie mindestens zwei Schnäpse täglich und Cannabiskonsum bis vor einem Jahr.
Die Familienanamnese ergab ein Kolorektalkarzinom beim Vater und seine Mutter ist an Hämatemesis im Alter von 66 Jahren verstorben.

Sozialanamnestisch ist er seit fünf Jahren arbeitslos, früher hat er als Schlosser gearbeitet. Er ist geschieden und hat eine Tochter.

Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf einen akuten Schub einer chronischen Pankreatitis hin.
Die ziehenden, kolikartigen Oberbauchschmerzen mit Ausstrahlung in den Rücken, dunkler Urin, helle und glänzende Diarrhoe, Gewichtsabnahme, Inappetenz und Nausea sprechen dafür.

Differentialdiagnostisch kommen ein Pankreaskarzinom, eine Choledocholithiasis, ein Ulcus ventriculi und ein ACS in Betracht.

Um die Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen, die Vitalparameter überwachen und Blut für das Labor abnehmen.
Außerdem ist es wichtig, ein EKG zu schreiben, um eine Herzerkrankung auszuschließen.
Bei der körperlichen Untersuchung werde ich auf Grey-Turner-, Cullen- und Fox-Zeichen sowie auf Ikterus achten.

Im Labor würde ich ein großes Blutbild, Entzündungsparameter (CRP, ggf. Procalcitonin/PCT), Lipase, Amylase, BZ, HbA1c, Elektrolyte, Herzenzyme (Troponin I/T, CK-MB), Cholestaseparameter (ALP, Gamma-GT, Bilirubin), Nierenwerte, Leberwerte, Lipidprofil sowie eine Stuhldiagnostik (Elastase-1) bestimmen lassen.

Anschließend werde ich eine Sonographie des Abdomens sowie ein CT-Abdomen mit Kontrastmittel und ggf. eine MRCP und ERCP bei biliärer Genese durchführen und ein Konsil in der Abteilung für Gastroenterologie und ggf. Chirurgie anfordern.

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, empfehle ich folgende Therapie:
Der Patient sollte intensivstationär aufgenommen werden.(monitorizieren)
Als initiale Therapie empfehle ich Flüssigkeitszufuhr, Elektrolytsubstitution und Nahrungskarenz(hasta instabil ise nahrunkkarenz, stabil ise egrek yokmuş).
Der Patient sollte eine symptomatische Behandlung erhalten, also Analgetika (z. B. NSAR, Tramadol, ggf. Pethidin), Antiemetika und einen PPI als Ulkusprophylaxe.
Eine Nikotin- und Alkoholkarenz wird verordnet. Eine Ernährungsumstellung wird empfohlen.
Darüber hinaus sollten bei nekrotisierender Pankreatitis ggf. Antibiotika, eine Enzymersatztherapie und ggf. Vitaminpräparate eingesetzt werden.
Anschließend werde ich ein Konsil in der Abteilung für Gastroenterologie anfordern.

Das Delirium tremens ist ein medizinischer Notfall. Die Behandlung besteht aus Benzodiazepinen zur Sedierung, Thiamin-Gabe, Flüssigkeits- und Elektrolytausgleich sowie engmaschiger Überwachung, meist auf der Intensivstation.

Reaktionen:

Warum haben Sie so viele Fragen an mich? Pankreatitis

Diese Fragen helfen mir, ein vollständige Bil Ihrer Gesundheit zu bekommen. Das ist wichtig für uns, um die richtige Diagnose zu stellen und die bestmögliche Behandlung zu planen.

Sie hat Blutsturz, Wissen Sie, was es bedeutet? Sie hat viel Blut auf den Tisch gespuckt, dann ist sie sofort zum KH gegangen und dort ist sie gestorben. Pankreatitis

Ja natürlich, das ist, wenn man Blut erbricht
Es tut mir sehr leid- Das äst schwere Erfahrung. Hat sie auch viel Alkohol getrunken? Das ist ein typisches Symptom einer alkoholbedingten Leberschädigung.
Ich bin seit 10 J. nicht mehr beim Hausarzt, weil ich gesund bin. Dessen Namen habe ich auch vergessen. Pankreatitis

Es ist gut, dass Sie gesund sind- Aber es ist trotzdem wichtig, regelmäßig Gesundheitschecks zu machen, auch wenn Sie sich gut fühlen, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Sie dürfen mindestens 1-mal pro Jahr Ihren Hausarzt besuchen.

Meine Frau ist mit einem Freund/ Kumpel angehauen, Könnten Sie es glauben? Pankreatitis

Es tut mir leid zu hören, dass Sie so etwas erleben mussten; es muss schwer für Sie gewesen sein.

Wasser Allergie? Pankreatitis

Es gibt jedoch keine bekannte Allergie gegen Wasser. Es ist möglich, der Alkoholkonsum führt zu häufigem Wasserlassen. Es ist wichtig, den Alkoholkonsum zu reduzieren, um Ihre Gesundheit zu schützen.

Rauchen aufhören: Pankreatitis

Okey aber 20 Zigaretten täglich ist zu viel. Haben Sie versucht mit dem Rauchen aufzuhören?

Wir können Sie dabei auch unterstützen, das wäre besser für Ihre Gesundheit auch.

Nikotinkonsum kann Ihrer Gesundheit schaden, insbesondere dem Herzen, den Lungen und den Blutgefäßen. Deshalb rate ich Ihnen, mit dem Rauchen aufzuhören.

Bitte werfen Sie das Handtuch nicht. Es ist völlig normal, dass es nicht beim ersten Versuch klappt. Viele Menschen brauchen mehrere Anläufe, um erfolgreich mit dem Rauchen aufzuhören. Es ist wichtig, dass Sie nicht aufgeben und erneut versuchen, das Rauchen aufzugeben.

Cannabis - Marihuana aufhören wegen Arbeitslosigkeit: Pankreatitis

Das freut mich, dass Sie aufgehört haben. Ich weiß, es geht hier um finanzielle Schwierigkeiten. Aber dies ist eine gesunde Entscheidung und wird sich positiv auf Ihre Gesundheit auswirken.

Alkohol aufhoren

Aus medizinischer Sicht ist der tägliche Konsum von Schnaps zu viel. Haben Sie versucht, mit dem Alkohol aufzuhören? Das kann die Ursache Ihrer Beschwerden sein. Wir können Sie dabei unterstützen, und ich kann Ihnen einen Spezialisten empfehlen, wenn Sie möchten.

Meine Kumpels haben mich gezwungen, hierher zu kommen. Sie haben gesagt, es geht nicht mehr. Ich habe Magenschmerzen und in den letzten 2-3 Wo. haben sich die Schmerzen verschlimmert, immer wenn ich etwas esse, bekomme ich sofort Schmerzen, dann trinke ich viel Bier.
Sie haben die richtige Entscheidung getroffen hierher zu kommen. Wir werden unsere Beste für Sie machen und um Ihre Beschwerden kümmern.

Was meinen Sie mit Ausstrahlung?
Ich meine die Übertragung von Schmerz von der Ursprungsstelle auf andere Körperregionen.

Habe ich Krebs?

Momenten denke ich nicht, aber wir werden das trotzdem überprüfen, um sicher zu sein. Aber bitte versuchen Sie positiv zu denken.

Was machen Sie mit mir? Woran denken Sie?

Ich habe einen Verdacht auf Bauchspeicheldrüsenentzündung, möglicherweise aufgrund Ihres Alkoholkonsums. Aber das bleibt nur eine Vermutung und wir sollen weitere Untersuchungen durchführen, um dies zu bestätigen. Ich werde zuerst Ihren Körper untersuchen und Ihnen etwas Blut abnehmen. Danach werden wir einen EKG, um eine Herzursache auszuschließen und einen Bauchultraschall durchführen,

Muss ich hierbleiben?
Das hängt von den Ergebnissen ab, aber möglicherweise müssen Sie zur Beobachtung bleiben.

Was ist EKG?
Ein EKG misst die elektrische Aktivität Ihres Herzens.

Was ist chronische Pankreatitis?
Das ist eine langfristige Entzündung der Bauchspeicheldrüse, die die Verdauung und den Zuckerstoffwechsel beeinflussen kann.

Was ist apparative Diagnostik?
Ultraschall, CT und MRT

Was ist eine Sono?
Ein Ultraschall des Bauchraums ist eine schmerzfreie und strahlenfreie Untersuchung, die etwa 15 Minuten dauert. Ein Gel wird auf Ihren Bauch aufgetragen und Ihre inneren Organe mit einer Sonde beobachtet.

Was ist CT/MRT?
CT und MRT sind bildgebende Verfahren, die detaillierte Bilder von Ihrem Körper liefern, um Erkrankungen besser zu erkennen.

Oberarzt-Assistanarztin

Was brauchen Sie am wichtigsten bei PD? Vor-, Nachname,
GD
Den Nachnamen buchstabieren? Woher kommt der Pat.?
Name: Dieter Kazmarek
Pollen
Wann war das GD? Was ist er für einen Tag? Vor Silvester. Alter: 59 (30.12.1962) (31.12) Am letzten Tag des Jahres 62

Welche genauere Angabe von Anamnese ist wichtig für den Fall? Hauptbeschwerden und Begleitsymptome

❓ Haben Sie nach der Stuhlfarbe gefragt?
→ Ja, ich habe gefragt.(Evet, sordum.)

❓ Was ist ein glänzender Stuhl? Warum?
→ Ein glänzender Stuhl enthält viel Fett. Er ist fettig, schwer abspülbar und spricht für Steatorrhö.(Parlak dışkı çok yağ içerir. Yağlıdır, zor temizlenir ve steatoreye işaret eder.)

❓ Welche Eigenschaften hat der Stuhl?
→ Hell, voluminös, übelriechend und fettig.(Açık renkli, hacimli, kötü kokulu ve yağlı.)

❓ Warum dunkler Urin?
→ Durch vermehrtes Bilirubin im Urin bei Gallenwegsverschluss.(Safra yolu tıkanıklığında idrarda artmış bilirubin nedeniyle.)

❓ Wovon wissen Sie, dass er Steatorrhö hat?
→ Durch fettigen, glänzenden, übelriechenden Stuhl.(Yağlı, parlak, kötü kokulu dışkıdan anlaşılıyor.)

Warum hat er abgenommen? Exokrininsuffizienz

📌 Tanım

- Exokrine Pankreasinsuffizienz = pankreasın dış salgı (exokrin) fonksiyonunun yetersizliği
- Yani: pankreasın sindirim enzimlerini (Lipase, Amylase, Protease) yeterli üretememesi.

📌 Sonuçları

- Besinler özellikle yağlar tam sindirilemez.
- Malassimilation / Malabsorption gelişir.
- Vücutta yağda eriyen vitamin eksiklikleri (A, D, E, K) ortaya çıkar.

📌 Kneipe / Bar

- Kneipe → daha çok mahalle pub'ı, küçük içkili mekân
- Bar → genellikle modern içkili mekân, kokteyl barı

📌 „Der Pat. schwindelt“

- Buradaki schwindeln = lügmek, doğruyu söylememek
- Yani hasta muhtemelen alkol tüketimini olduğundan az söylüyor.

📌 Ugs. (umgangssprachlich = günlük konuşma dili) → Alkol almak için deyimler

- zu tief ins Glas schauen→ çok içmek (kelime anlamı: bardağa fazla bakmak)
- saufen→ kafayı çekmek (argo, kaba)
- sich besaufen→ sarhoş olmak (içip kafayı bulmak)
- sich berauschen→ kendini uyuşturmak, sarhoş olmak
- versoffen sein→ sürekli sarhoş, ayyaş olmak
- sich volllaufen lassen→ kendini içkiye boğmak, çok içmek
- sich einen ansäulen (ugs., kaba)→ kafayı çekmek
- sich bezechen→ iyice içmek, kafayı bulmak
- Schluckspecht→ çok içen kişi, ayyaş (kelime anlamı: yudumlayan ağaçkakan)

Stroh (Alkohol) → çok sert rom (Stroh Rum)
in Eckkneipen sein → mahalle barlarında takılmak / içki içmek

Wo kann man in DL-Alkohol trinken? Kneipe, Bar
Der Pat. schwindelt => lügt, er trinkt wahrscheinlich mehr
Ugs. Alkohol trinken: zu tief ins Glas schauen, saufen, sich besaufen, berauschen, versoffensein, sich volllaufen lassen, sich einen ansäulen, sich bezechen, Schluckspecht
Was bedeutet Stroh? Alkohol
Was bedeutet in Eckkneipen sein?
Alkoholentzugssymptome als Fachbegriff? Delirium tremens

Kennen Sie das Sprichwort “der Apfel fällt nicht weit weg vom Baum”? Wie lässt es sich in diesem Fall Übersetzen?

Seine Mutter war wahrscheinlich auch Alkoholiker.
Welches Hobby hat die Mutter? Alkohol trinken

Warum Hämatemesis? Ösophagusvarizen

MCV => Wie lange man Alkohol trinkt?
Erhöhtes MCV kann auf chronischen Alkoholkonsum hinweisen“)

Was macht der Pat. beruflich? Arbeitslos Warum ist es wichtig zu wissen, was er früher gemacht hat?
Was ist Arbeitslosengeld?
Arbeitslosenversicherung. Sie soll helfen, finanzielle

Notlagen bei Arbeitslosigkeit zu verhindern und wird in
Abhängigkeit von Anwartschaftszeiten und Lebensalter für
drei bis längstens 24 Monate gezahlt.
Wie kommt er durch seinen Tag? Wo verbringt er am liebsten Zeit? Eckkneipen, Trinken, Fernsehen

📌 İşsizlik sigortası:
İşsizlik sırasında mali sıkıntıları önlemeye yardımcı olmayı amaçlar ve sigortalılık süresi ile yaşa bağlı olarak 3 aydan en fazla 24 aya kadar ödenir.

Begründen: Steatorrhö, Gewichtsverlust, Bauchschmerzen
Was bedeutet exokrine und endokrine Pankreasinsuffizienz?

Bei der exokrinen Pankreasinsuffizienz kommt es zu einer unzureichenden Sekretion von Verdauungsenzymen, insbesondere Lipase und Amylase.
Dadurch entsteht eine Maldigestion von Fetten und fettlöslichen Vitaminen, was zu Diarrhö, Steatorrhö und Gewichtsabnahme führen kann.
Im Labor zeigt sich eine verminderte Elastase-1-Konzentration im Stuhl (<100 µg/g Stuhl).
Therapeutisch erfolgt eine Substitution mit Pankreatin (z. B. Schweine-Pankreatin oder Rizoenzymen).

Bei der endokrinen Pankreasinsuffizienz besteht ein Mangel an Insulin und/oder Glukagon.
Durch den Insulinmangel entwickelt sich ein diabetes mellitus (Insulinmangeldiabetes).
Im Labor findet man erhöhte Glukose- und HbA1c-Werte.
Die Therapie besteht in einer Insulin-Substitution (Basal- und Bolusinsulin).

Was können wir in der Sonografie sehen?

- Verkalkungen des Pankreases
- Unregelmäßigkeiten des Pankreasgangs
- Steine und Pseudozysten

Was sind Pseudozysten?
Pseudozysten sind keine echten Zysten, sondern entzündungsbedingte Flüssigkeitsansammlungen ohne Epithelwand, meist nach Pankreatitis.

Wie behandeln wir sie?

Die Behandlung richtet sich nach der Größe und Lokalisation der Pseudozyste.
Kleine, asymptomatische Pseudozysten können konservativ behandelt und im Verlauf beobachtet werden, da sie sich oft spontan zurückbilden.
Bei symptomatischen oder großen Zysten kann eine Entlastungspunktion erfolgen.
In einigen Fällen ist eine operative Drainage notwendig.

KU? Gummibauch, Abwehrspannung

📌 Gummibauch
- Türkçesi: *“Lastik karın” / “lastiksi karın”
- Tanım: Karın duvarı palpasyonda elastik, lastiksi bir direnç gösterir.
- Genellikle subakut veya kronik peritonit bulgusu.
- Karın sert ama taş gibi değil, daha “esnek” bir şekilde sertleşmiştir.

📌 Abwehrspannung
- Türkçesi: *“Defans” / “karın duvarında koruyucu kasılma”
- Tanım: Karın duvarı kaslarının, palpasyona karşı refleks olarak kasılması
- Neden: Peritoneal irritasyon (örn. akut apandisit, peritonit)
- Palpasyonla hasta istemsiz kasılır, karın sertleşir.
- Bu bulgu, akut batın için tipiktir.

Laborbericht: Amylase, Lipase > 3 Fach, Leukozyten erhöht, Bilirubin erhöht
Bestätigt es Ihre VD? Belegten meine VD-Lipase und Amylase,
welche spezifischer? Lipaz
Was ist PCT? Procalcitonin, Marker für bakterielle Infektionskrankheiten (z.B. Sepsis)

Was ist HbA1c? Langzeitblutzucker, BZ in den letzten 3 Monaten. Warum HbA1c?
Was gehört zu den Nierenwerten, Herzmuskelenzymen, Entzündungsparametern?
- Nierenwerten: Kreatinine, Harnsäure
- Herzmuskelenzyme: CKMB, Troponine I, T
- Entzündungsparameter: CRP , BSG ggf. PCT

Ist Sonografie gut für Pankreas-Krankheiten? Nicht aussagekräftig

nicht aussagekräftig“
📌 Türkçesi:
- Anlamlı değil
- Yeterli bilgi vermiyor
- Sonuç çıkarmaya elverişli değil

📌 Retrograd = rückläufig, entgegen der normalen Flussrichtung
→ also gegen den natürlichen Fluss der Gallen- und Pankreassäfte

🔹 In der Praxis:

- Normalerweise fließt die Galle von der Leber über die Gallengänge → in den Zwölffingerdarm.
- Bei der ERCP geht man vom Zwölffingerdarm rückwärts (retrograd) durch die Papilla Vateri in die Gallengänge und ggf. in den Pankreasgang.

🔹 Warum macht man das so?

- Um Kontrastmittel „gegen den Strom“ einzuspritzen → damit man die Gallengänge und den Pankreasgang im Röntgenbild sichtbar machen kann.
- Um Engstellen (Stenosen), Steine, Tumoren oder Entzündungen zu erkennen – oder therapeutisch einzugreifen (z. B. Steinextraktion, Stent legen).

🧠 Merksatz:
„Retrograd“ in ERCP = vom Darm aus zurück in die Gallen- und Pankreasgänge.

Wann machen Sie ERCP?
Was bedeutet retrograd in ERCP? Rückläufig, in Gegenrichtung des Fluss von Gallensäure

Nehmen Sie den Pat. auf? Welche Station?
Welches Konsil?
Wie rechnen Sie der Enzymersatzt?
Welche Vitamine geben wir dem Pat.? DAKE, Folsäure (fettlöslich)
Geben Sie dem Pat. Metformin?

Unterschied zwischen Empyem und Abszess?
Ein Abszess ist eine Eiteransammlung in einem neu entstandenen Gewebehohlraum, während ein Empyem eine Eiteransammlung in einer bereits bestehenden Körperhöhle ist.“

Pankreatitis

- **Patient/ Patientin Datum (Vorname, Name, Geb.-Datum)**

Name: Theo Sarbovski
Alter: 59 Jahre (geb. am 31.12.1962)
Größe: 1,83 m
Gewicht: 74,3 kg

- **Aufnahmegrund/ Diagnose (stichwortartig)**

Hauptbeschwerde:

- seit 3 Wochen, langsam aufgetretene, bestehende, kolikartige, ziehende Bauchschmerzen im Epigastrium, mit gürtelförmiger Ausstrahlung in den Rücken.
- Die Schmerzintensität: 5-6/10 auf der NRS
- Auslöser: nach dem Verzehr von Eiersalat mit Brot und Butter
- Lindernde Faktoren: Sitzen
- Verstärkende Faktoren: Stehen
- Ähnliche Beschwerden: Seit 3 Jahren (leichter, postprandil)

Begleitsymptome:

- Nausea: seit 3 Wo., persistierend
- Meteorismus, Völlegefühl
- Diarrhö: dünnerstuhl, hellbraun, glänzend, 4-5 Mal/T. , manchmal nachts, ohne Blut
- Dunkler Urin seit 3 T. Trot des Polydipsie

V/A:

- Inappetenz
- Gewichtsverlust (5 kg in 4-5 Wo.)
- Müdigkeit
- Nachtschweiß
- Insomnie wegen Diarrhö / Schmerzen, seit 3 Wo.

V/E:

Clavus

M:

Keine

Vor-op:

Vor 29 Jahren Osteosynthese der rechten Tibia- und Fibulafraktur nach Verkehrsunfall. Komplikation: starke Blutung.

- **Allergien/ Unverträglichkeiten:**

unauffällig

- **Genussmittel/ Drogen:**

- Nikotinkonsum: 20 Zig./T. ,seit 40 J.
- Alkoholkonsum: 3–4 Flaschen Bier/T seit ca. 30J. + zusätzlich mind. 2 Schnaps/T
- Drogenkonsum: Cannabis, 2–3 Joints, alle 2–3 Wo., zuletzt vor 1 J.

- **Sozialanamnese:**
  Arbeitslos seit 5 J.,
  früher Schlosser und Dreher
  Geschieden seit 10 J.
  eine Tochter (25 J.), kaum Kontakt

- **Familienanamnese:**
  Vater: verstorben mit 60 Jahren an kolorektalem Karzinom
  Mutter: verstorben mit 65 Jahren (Hämatemesis, unklare Todesursache)
  GroßVater: verstorben mit 70 Jahren an Magenkarzinom

- **Verdachtsdiagnose:**
  Akuter Schub einer chronischen Pankreatitis

- **Differentialdiagnose**
  Ulcus ventriculi
  Pankreaskarzinom
  Magenkarzinom

- **weitere Diagnostik**
- KU
- EKG
- Labor: großes BB - CRP - BSG - BZ - Leberwerte - Nierenwerte - Amylase und Lipase - Elektrolyte - Cholestaseparameter
- Stuhluntersuchung
- Sono Abdomen
- Ggf CT Abdomen
- Gastroenterologisches Kosil

- **Therapievorschläge**
- Intensive stationäre oder stationäre Aufnahme
- Flüssigkeitszufuhr und Elektrolytsubstitution (Infusionstherapie)
- Nahrungskarenz
- Antiemetikum
- Analgetikum (Metamizol) b.B.
- Ggf. Antibiotikum (Ceftriaxon und Metronidazol)

- druckschmerzhaftigkeit der rechte Unterbauch (2 Punkte)
- Loslassschmerz
- Fieber (ab 37,3 °C)
- Leukozytose über 10.000 /µl (2 Punkte)
- Linksverschiebung im Differentialblutbild

Mesenterialinfarkt

= Mesenterialarterienstenose ist eine Verengung (Stenose) oder kompletter Verschluss einer Mesenterialarterie mit anschließender Infarzierung und Nekrose des versorgten Darmabschnitts.

Ätiologie: in den meisten Fällen durch eine arterielle Embolie oder lokale Thrombose nach dem Truncus coeliacus. Risikofaktor:

- Arteriosklerose
- Vorhofflimmern
- Versorgung eines Bauchaortenaneurysmas

Warum Nüchternzustand?
Essen regt die Bauchspeicheldrüse an. Bei einer Pankreatitis soll sie sich aber beruhigen - deshalb darf man vorübergehend nichts essen.

Klinik: 3 Phasen

1) **Initialstadium** (0-6h): abdominelle kolikartige Schmerzen mit Nausea, Emesis, Diarrhö, starke Inappetenz +/- ungewollten Gewichtsverlust (Abdomen klinischen unauffällig)
2) **Latenzstadium** (6-12h) = „trügerischer Frieden": symptomatischen Verbesserung und Meteorismus. In dieser Phase setzt die Wandnekrose ein.
3) **Spätstadium** (> 12h): Peritonitis mit Entwicklung eines Schocks. Klinisch: akutes Abdomen mit Abwehrspannung

Diagnostik:

- KU: Abwehrspannung und bei der Auskultation ⊐ fehlende Darmgeräusche
- Labor: LDH und Laktat ↗ (häufig auch Leucoytose)
- Duplex-Sonographie und Angiographie
- Ggf. CT-Angiographie

Therapie:

- Laparoskopie bzw. Laparotomie: Thrombenarteriektomie durch Fogarty-Katheter / Revaskularisation durch Bypass zwischen Aorta und stenosiertem Gefäß
- Postoperative Antikoagulation mit Heparin, folgend mit Cumarinderivaten

12. Akuter schub chronischer Pankreatitis s.97

1

Arzt-Patient-Gespräch

-Name, Geburtsdatum, Gewicht, Größe

Spricht schnell (insb. Nummern), sehr viel und murmelt ein bisschen

- Dieter Kazmarek / Theo Sarbovski
- 59 J.
- *31.12.1962: Am letzten Tag des Jahres 62
- 1,83 m
- 74,3 kg

* damit wir Sie nicht mit anderen Patienten, mit gleiche Namen verwechseln...

- Warum fragen Sie nochmal? Ich habe schon alles bei der Anmeldung gegeben.
  - Das ist wichtig für uns die Daten nochmal überprüfen, um ~~die Patienten nicht verwechseln~~ Sie nicht mit anderen Patienten mit gleichen Namen und Alter zu verwechseln.

-Hauptbeschwerde

- Meine Kumpels haben mich gezwungen, hierher zu kommen. Sie haben gesagt, es geht nicht mehr. Ich habe Magenschmerzen und in den letzten 2-3 Wo. haben sich die Schmerzen verschlimmert, immer wenn ich etwas esse, bekomme ich sofort Schmerzen, dann trinke ich viel Bier.

- Sie haben die richtige Entscheidung getroffen hierher zu kommen. Wir werden unsere Beste für Sie machen und um Ihre Beschwerden kümmern.

- Bauchschmerzen
  - Seit 3 Jahre / 3 Monaten
  - Epigastrium: Oberbauch und manchmal im ganzen Bauch, hoch und um den Nabel herum
  - Ohne Ausstrahlung / Ausstrahlung beidseitig: Die Schmerzen ziehen in den Rücken. ~~Was meinen Sie mit Ausstrahlung?~~ Kolonbestrahlung
    - Ich meine die Übertragung von Schmerz von der Ursprungsstelle auf andere Körperregionen.
  - Anfallsartig
  - Progredient: in den letzten 2-3 Wochen deutlich zugenommen
  - Persistierend
  - Ziehend, kolikartig, gürtelförmig
  - Am Anfang nur postprandial (circa 30-60 Minuten), seit 2-3 Wochen persistierend
  - Auslöser: Nach dem Verzehr von Eiersalat mit Brot und Butter
  - Alkohol und Wärmekisse bringen nichts
- Diarrhö: (Aufgrund des Mangels Verdauungsenzymen {Amylaz, Lipaz *, Protease})
  - Seit 2 Wochen / 3 Monaten
  - 4-5 Mal / d
  - Dünner Stuhl, Hellbraun, glänzend: Haben Sie in letzter Zeit bemerkt, dass Ihr Stuhlgang fettig oder ölig aussieht? (☐ *Steatorrhö*)
  - Manchmal nachts
  - Ohne Blut
- Nausea und Emesis
  - Anhaltend
  - Seit 3 Wochen
- Nachtschweiß: Ich wache auf in der Nacht und meine Kleidung ist durchgenässt
- Fatigue / Asthenie (Erschöpfung)
- Meteorismus (Blähungen)
- Vollgefühl
- Urin
  - Seit ein paar Tagen dunkler wie Altbier → (gallengangobstruktionen)
  - ~~Kein Dysurie / Hämaturie~~
- ~~Kein Reflux, Ructus, pektanginöse Beschwerden~~

-vegetative Symptomatik

- Inappetenz
- Gewichtsverlust circa 5/10 kg innerhalb von 4-5 Wochen War das ungewollt?
- Dyssomnie wegen Diarrhö / Schmerzen

-Vorerkrankungen

- ~~Ich weiß nicht, ich bin seit 10 Jahren nicht mehr beim HA, weil ich gesund bin. Dessen Namen habe ich auch vergessen~~ Es ist gut, dass Sie gesund sind.
  - Aber es ist trotzdem wichtig, regelmäßig Gesundheitschecks zu machen, auch wenn Sie sich gut fühlen, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Sie dürfen mindestens 1-mal pro Jahr Ihren Hausarzt besuchen.
- Clavus (Hühnerauge)

-Vor-OPs

- ~~Warum haben Sie so viele Fragen an mich?~~
  - Diese Fragen helfen mir, ein vollständige Bil Ihrer Gesundheit zu bekommen. Das ist wichtig für uns, um die richtige Diagnose zu stellen und die bestmögliche Behandlung zu planen.

- Vor 29 J.: hatte ich ein Autounfall. Ich hatte Wade- und Scheinbeinbruch und wurden mit schrauben und platten fixiert.
  - Komplikation: starke Blutung, 4 Bluttransfusion
    - Es tut mir leid, das ist eine schwierige Situation

wurde 4 Blutkonserven transfundiert.

-Medikation

- Ich nehme Schnaps ein 1-1-1-1
  - Aus medizinischer Sicht ist der tägliche Konsum von Schnaps zu viel. Haben Sie versucht, mit dem Alkohol aufzuhören? Das kann die Ursache Ihrer Beschwerden sein. Wir können Sie dabei unterstützen, und ich kann Ihnen einen Spezialisten empfehlen, wenn Sie möchten.

-Allergien

- Gibt es Wasserallergie? Ich bin allergisch gegen Wasser meinen meine Freude (sie meinen ich trinke zu viel Bier und muss deswegen häufig auf die Toilette)
  - Nein es gibt kein Wasserallergie. Sie dürfen mit dem Alkohol aufzuhören, das ist nicht witzig und sehr wichtig für Ihre Gesundheit.

Nein, es gibt keine Wasserallergie. Es ist möglich, der Alkoholkonsum führt zu häufigem Wasserlassen. Es ist wichtig, den Alkoholkonsum zu reduzieren, um Ihre Gesundheit zu schützen.

-Noxen

- Nikotinabusus: 20 Zig / d seit 40 J. (40 py) mit dem 17-18 LJ
  - Haben Sie versucht mit dem Rauchen aufzuhören?
    - Ich habe es einmal versucht, aber dann habe ich weiter geraucht.
      - Wir können Sie dabei auch unterstützen, das wäre besser für Ihre Gesundheit auch.
- C2: 3-4 Fl. Bier/d seit 30 J. mindestens 2 Schnaps/d
  - Wie viel ist eine Flasche Bier?
- Drogen: +/- Marihuana 2-3 Joints alle 2-3 Wochen. Seit einem Jahr nicht mehr, weil ich nicht genug Geld habe
  - Das freut mich, dass Sie aufgehört haben. Selbst wenn Sie in Zukunft mehr Geld haben sollten, wäre es besser, nicht wieder anzufangen, da Marihuana gesundheitliche Risken mit sich bringen kann.

Aber 20 Zigaretten täglich ist zu viel. Nikotinkonsum kann Ihrer Gesundheit schaden, insbesondere den Herzen, den Lungen und den Blutgefäßen. Deshalb rate ich Ihnen mit dem Rauchen aufzuhören.

esor icikmsigara

-Sozialanamnese

Ich weiß, es geht hier um finanzielle Schwierigkeiten. Aber dies ist eine gesunde Entscheidung und wird sich positiv auf Ihre Gesundheit auswirken.

- Beruf: Arbeitslos seit 5 J. Früher: Schlosser und Dreher (Metalbauarbeit) Was haben Sie früher gemacht?
- Geschieden seit 10 J.: Meine Frau ist mit einem Kumpel angehauen, Könnten Sie es glauben?
  - Es tut mir leid zu hören, dass Sie so etwas erleben mussten; es muss schwer für Sie gewesen sein.
- 1 Tochter (25 J.): kaum Kontakt
- Sport: -
- Hobby: Fernsehen, Kneipe
  - Also Herr Kazmarek, um Ihre Gesundheit zu verbessern und zu verhindern, dass sich Ihr Zustand verschlechtert, ist es sehr wichtig, dass Sie vollständig aufhören zu trinken und zu rauchen und sich regelmäßig Sport treiben, mindestens einmal pro Woche. Sie können auch mindestens 30 Minute pro Tag spazieren zu gehen.
  - Wenn Sie hierher gekommen sind, wollen Sie gesund werden? Dann ist es an der Zeit, Ihre Gewohnheiten zu ändern!

Schlosser – Kaynak Ustası
Dreher – Torna Ustası

-Familienanamnese

- Vatter (86 J.): Kolorektal-CA: Dickdarmkrebs
- Mutter (66 J.): t an Hämatemesis im KH.
  - Sie hat Blutsturz, Wissen Sie, was es bedeutet?
    - Ja natürlich, das ist, wenn man Blut erbricht

Kan kusma

Es ist an der Zeit, ...
(zamanıdır, ...

- Sie hat viel Blut auf den Tisch gespuckt, dann ist sie sofort zum KH gegangen und dort ist sie gestorben.
  - Es tut mir sehr leid, hat sie auch viel Alkohol getrunken? Das ist ein typisches Symptom einer alkoholbedingten Leberschädigung.
- GroßV (70 J.): t mit 70 an Magen-CA.
  - Habe ich Krebs?
    - Momenten denke ich nicht, aber wir werden das trotzdem überprüfen, um sicher zu sein. Aber bitte versuchen Sie positiv zu denken.

⇨ Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit, ich bin nun mit meinen Fragen fertig.

Ich habe einen Verdacht auf **Bauchspeicheldrüsenentzündung**, möglicherweise aufgrund Ihres Alkoholkonsums. Aber das bleibt nur eine Vermutung und wir sollen weitere Untersuchungen durchführen, um dies zu bestätigen.

Ich werde zuerst Ihren Körper untersuchen und Ihnen etwas Blut abnehmen. Danach werden wir einen EKG, um eine Herzursache auszuschließen und einen Bauchultraschall durchführen, wissen Sie was das ist?

Sonographie:

Ein Ultraschall des Bauchraums ist eine schmerzfreie und strahlenfreie Untersuchung, die etwa 15 Minuten dauert. Ein Gel wird auf Ihren Bauch aufgetragen und Ihre inneren Organe mit einer Sonde beobachtet.

-Fragen

- Muss ich hier bleiben?
  - Das hängt von den Ergebnissen ab, aber möglicherweise müssen Sie zur Beobachtung bleiben.
- Was ist EKG?
  - Ein EKG misst die elektrische Aktivität Ihres Herzens.
- Was ist chronische Pankreatitis?
  - Das ist eine langfristige Entzündung der Bauchspeicheldrüse, die die Verdauung und den Zuckerstoffwechsel beeinflussen kann.
- Was ist CT/MRT?
  - CT und MRT sind bildgebende Verfahren, die detaillierte Bilder von Ihrem Körper liefern, um Erkrankungen besser zu erkennen.

Haben Sie noch Fragen?

Arzt-Arzt-Gespräch

Guten Tag. Mein Name ist Masson. Ich arbeite seit kurzem als Assistenzärztin in der Ambulanz/Notaufnahme.

Es geht um Herr **Dieter Kazmarek, 59** Jahre alt, der in reduziertem AZ (Allgemeinzustand) und gutem EZ (Ernährungszustand) gekommen ist.

Er beschreibt Ihre aktuellen Symptome wie folgt: seit 3 Wochen gürtelförmige epigastrische Schmerzen, die in den Rücken ausstrahlen. Die Schmerzen haben langsam vor 3 Monaten begonnen, aber anfallsartig und postprandial und sind seitdem progredient und seit 3 Wochen auch persistierend. Sie sind ziehend, kolikartig und 6 von 10 auf einer Schmerzskala.

Begleitend sind seit 3 Wochen Diarrhö, circa 5 Stuhl pro Tag, die dünner, hell und glänzend aussieht. Nausea, Emesis, Nachtschweiß, Müdigkeit, Meteorismus und Vollgefühl. Seit ein paar Tagen, hat er dunkler Urin bemerkt.

Er berichtet auch ungewollte Gewichtsverlust von 5 kg innerhalb 4 Wochen, Inappetenz und Dyssomnie wegen Diarrhö und Schmerzen. **Ansonsten ist die weitere vegetative Anamnese unauffällig.**

Der Patient raucht 40 py (20 Zig/d seit 40 J.) und trinkt 4 Flasche Bier und mindestens 2 Schnaps pro Tag seit 30 Jahren.

In der Familienanamnese gibt es Kolorektal-Karzinom, Magen-Karzinom, und seine Mutter ist an Hämatemesis gestorben (möglicherweise Ruptur von Ösophagusvarizen im Zusammenhang mit Leberzirrhose).

Das wäre zunächst dem Relevanten.

Aufgrund der Anamnese habe ich den Verdacht auf Akuter schub chronischer Pankreatitis. An Differentialdiagnosen sind zu nennen, Cholezystitis, Hinterwandinfarkt

Als erstes werde ich eine körperliche Untersuchung durchführen; dann halte ich eine Laboruntersuchung mit Bestimmung: gr. BB, Entzündungsparameter (CRP, BSG, ggf. PCT), Gerinnungsparameter (Quick-Wert, PT, INR), Amylase, Lipase, Leber-Nierenwerte, Cholestase-Werte, E-lyte, Herzenzyme (Trop.I, T, CKMB), Glukose, (*HbA1c*), Vitaminprofil (VitB12 und Folsäure), Tumormarker (CEA, CA19-9), Stuhluntersuchung (Elastase-1).

Anschließend ist eine Sonographie des Abdomens. Auch sollte ein Ruhe-EKG durchgeführt werden, um eine kardiale Ursache auszuschließen. Ggf. CT-Abdo mit KM, ERCP (bei biliärer Genese), ÖGD + Biopsie. Weiterführend ist ein Gastroenterologische Konsil anzufordern.

Ich werde ihm intensivstationäre aufnahmen.

Als Konservativtherapie, empfehle ich Volumen- Elektrolytsubstitution (Ringer-Laktat-Infusion), Nulldiät (keine Feste Nahrungsmittel), Analgetikum, Plasmapherese (bei Hypertriglyzeridämie über 1000 mg/dl), Antibiotikum (Carbapenem, Ceftriaxon, Metroidazol), PPI. Und auch natürlich Lebenstilveränderung: Alkoholkarenz, Nikotinkarenz, Sport. Ggf. antidiabetische Therapie bei einer endokrinen Pankreasinsuffizienz / Pankreatin bei exokrine Pankreasinsuffizienz.
Ggf. als Operativetherapie, schlage ich eine duodenumerhaltende Pankreaskopfresektion (= Whipple-Operation) vor.

Sind Sie mit meinem /diesem Vorgehen einverstanden?

-Fragen

Was brauchen Sie am wichtigsten bei PD? Vor-, Nachname, GD

Den Nachnamen buchstabieren?

Woher kommt der Pat.? Pollen

Wann war das GD? Was ist er für einen Tag? Silvester

Welche genauere Angabe von Anamnese ist wichtig für den Fall? Hauptbeschwerden und Begleitsymptome

Haben Sie nach der Stuhlfarbe gefragt?

Was ist ein glänzender Stuhl? Warum?

Welche Eigenschaften hat der Stuhl?

Warum dunkler Urin?

Wovon wissen Sie, dass er Steatorrhö hat?

Warum hat er abgenommen? Exokrininsuffizienz

Alkoholgehalt

- Bier 5%
- Champagner 11%
- Wein 12-14%
- Sake 15%
- Shochu 25-35%
- Whisky 40%
- Schnaps 40%
- Liquor 40%

Wo kann man in DL Alkohol trinken? Kneipe, Bar

Der Pat. schwindelt => lügt, er trinkt wahrscheinlich mehr

Ugs. alkohol trinken: zu tief ins Glas schauen, saufen, sich besaufen, berauschen, versoffensein, sich volllaufen lassen, sich einen ansäulen, sich bezechen, Schluckspecht

Was bedeutet Stroh? Alkohol

Was bedeutet in Eckkneipen sein? eine Bar in seiner Nähe / Viertel

MCV => Wie lange man Alkohol trinkt?

Was sind die Alkoholentzungssymptome?

- Gastrointestinaltrakt: Nausea, Diarrhoe
- Herz-Kreislauf: Tachykardie, Hypertonie
- Vegetatives Nervensystem: Hyperhidrosis, Schlafstörungen, Mydriasis, Fieber, Gesichtsrötung
- Somatisches Nervensystem, feinschlägiger Tremor, Nesteln, Artikulationsschwierigkeiten, Wortfindungsstörungen, epileptiforme Anfälle
- Psyche: Agitiertheit, Angst, Depressionen

Wie viel ist eine Flasche Bier? 330 oder 500 ml

Alkoholentzugssymptome als Fachbegriff? Delirium tremens

Was macht der Pat. beruflich? Arbeitslos

Warum ist es wichtig zu wissen, was er früher gemacht hat? Um herauszufinden, ob er an einer Berufskrankheit leiden kann

Was ist Arbeitslosengeld? ist die Hauptleistung der Arbeitslosenversicherung. Sie soll helfen, finanzielle Notlagen bei Arbeitslosigkeit zu verhindern und wird in Abhängigkeit von Anwartschaftszeiten und Lebensalter für drei bis längstens 24 Monate gezahlt.

Wie kommt er durch seinen Tag? Wo verbringt er am liebsten Zeit? Eckkneipen, Trinken, Fernsehen

Kennen Sie das Sprichwort "der Apfel fällt nicht weit weg vom Baum"? Wie lässt es sich in diesem Fall übersetzen? Seine Mutter war wahrscheinlich auch Alkoholiker.

Welches Hobby hat die Mutter? Alkohol trinken

Warum Hämatemesis? Ruptur von Ösophagusvarizen

Komplikationen der Leberzirrhose?

- **Portale Hypertension** = Druck in der Pfortader > 12 mmHg
  - Bauchwandvarizen: Caput medusae (Nabelregion)
  - Ösophagus-,Fundusvarizen ⇒ ein Symptom der **Varizenruptur** ist oft schwallartiges Bluterbrechen. Eine Ösophagusvarizenblutung hat eine Letalität von bis zu 30 %.
- Bei zunehmendem Versagen der Leberfunktion (**Dekompensation**) kommt es zu(m):
  - **Aszites** durch Albuminmangel und portale Hypertension mit dem Risiko einer spontan bakteriellen Peritonitis durch bakterielle Translokation

  - Hypersplenismus bzw. **Splenomegalie** (ca. 75 % der Fälle)
  - Hämorrhagischer Diathese
  - erhöhtem Infektionsrisiko (z.B. für eine bakterielle Pneumonie), aufgrund von verminderter hepatischer Produktion von Komplementfaktoren und Antikörpern
  - Kachexie
  - Malnutrition sowie Vitamin- und Spurenelemente-Mangel
  - Hepatischer Enzephalopathie bis hin zum Vollbild des Coma hepaticum
  - hepatopulmonalem Syndrom
  - hepatorenalem Syndrom
- **Leberzellkarzinom**

Begründen für Akute Schub von chronischer Pankreatitis? Steatorrhö, Gewichtsverlust, epigastrische und gürtelförmige Bauchschmerzen, die sich seit mehreren Monaten langsam entwickeln.

Was sind typische Symptome?

- Akute Pankreatitis: Plötzlich einsetzende starke gürtelförmig ausstrahlende Oberbauchschmerzen, N/V, Meteorismus, Ikterus, Aszites bzw. Pleuraerguss
- Chronische Pankreatitis: Rezidivierende postprandiale, gürtelförmig in den Rücken ausstrahlende Oberbauchschmerzen, Progredienter Gewichtsverlust

Was ist die häufigste Ursache einer Pankreatitis?

- Akute Pankreatitis
  - Choledocholithiasis 45%
  - Alkoholmissbrauch 30%
  - Idiopathisch 20%
- Chronische Pankreatitis
  - Alkoholabusus 90%

Was bedeutet exokrine und endokrine Pankreasinsuffizienz?

- **Exokrine Pankreasinsuffizienz**:
  - Fehlende Verdauungsenzymensekretion = ↘ Lipase und Amylase
  - ☐ Maldigestion von Fetten und Vitamin ☐ Diarrhö, Steatorrhö ☐ Gewichtsabnahme
  - Labor: Elastase-1-Konzentration im Stuhl (< 100 µg)
  - Therapie: Substitution ☐ Schweine-Pankreatin oder Rizoenzymen
- **Endokrine Pankreasinsuffizienz**:
  - Mangel an Insulin und / oder Glukagon
  - ☐ Insulinmangeldiabetes
  - Labor: Glucose, HbA1c
  - Therapie: Basalinsulin / Bolusinsulin

Was können wir in der Sonografie sehen?

- **Verkalkungen** des Pankreases
- **Unregelmäßigkeiten** des Pankreasgangs
- Steine und Pseudozysten

Was sind Pseudozysten? flüssigkeitsgefüllte Kammern im Bereich der Bauchspeicheldrüse (Pankreas), die nach akuten oder chronischen Entzündungen (Pankreatitis) auftreten können.

Wie behandeln wir sie?

- Abhängig von der Größe und Lokalisation
- Konservativ, Verlaufsbeobachtung, sich spontan zurückbilden
- Entlastungspunktion
- Operative Drainage

KU? Abwehrspannung (= Gummibauch)

Laborbericht:

- **Amylase, Lipase > 3 Fach**
- **Leukozyten erhöht**
- **Bili erhöht**

Bestätigt es Ihre VD? Belegt meine VD

Lipase und Amylase, welche spezifischer? Lipase

Was ist PCT? Procalcitonin, Marker für bakterielle Infektionskrankheiten (z.B. Sepsis)

Was ist HbA1c? Langzeitblutzucker, BZ in den letzten 3 Monaten

Was gehört zu den Nierenwerten, Herzmuskelenzymen, Entzündungsparametern?

- **Nierenwerten: Kreatinine, Harnsäure**
- **Herzmuskelenzyme: CKMB, Troponine I, T**
- **Entzündungsparameter: CRP, BSG ggf. PCT**

Ist Sonografie gut für Pankreas-Krankheiten? Die Abdomensonographie gehört zur Basisdiagnostik, um eine biliäre Genese hinzuweisen.

- Bei akutem Verlauf können wir Peripankreatische freie Flüssigkeit (durch intrapankreatische Aktivierung der Verdauungsenzyme).
- Bei chronischem Verlauf können wir auch Verkalkungen, Pseudozysten beobachten.

Bei einem unklaren sonographischen Befund → MRT oder MRCP

Wann machen Sie ERCP? Bei biliärer Genese mit begleitender Cholangitis oder nachgewiesener Choledocholithiasis ist eine endoskopische retrograde Cholangiopankreatikographie (ERCP) zur Beseitigung der Choledochus-Obstruktion mittels Sphinkterotomie angezeigt.

Nehmen Sie den Pat. auf?

Welche Station?

Welches Konsil?

Wie rechnen Sie der Enzymersatzt?

Welche Vitamine geben wir dem Pat.? ADEK (fettlöslich), ggf. VitB12 und Folsäure

Geben Sie dem Pat. Metformin? Nein, was die endokrine Pankreasinsuffizienz bedeutet Mangel an Insulin

Reha (Rehabilitation): Unter Rehabilitation versteht man in der Medizin die Wiederherstellung der physischen und/oder psychischen Fähigkeiten eines Patienten im Anschluss an eine Erkrankung, ein Trauma oder eine Operation. Als Sekundärziel soll eine Wiedereingliederung in das Sozial- und Arbeitsleben erreicht werden.

Unterschied zwischen Empyem und Abszess?

- **Abszess** = eine abgekapselte Ansammlung von Eiter in einem nicht präformierten, durch Einschmelzung von Zellen neu gebildeten Gewebshohlraum. Den Vorgang der Abszessbildung bezeichnet man mit dem Begriff Abszedierung.
- **Empyem** = eine umschriebene Ansammlung von Eiter in einer präformierten Körperhöhle oder einem Hohlorgan.

Erschöpfung? Fatigue

Was ist Aszites? Ursachen? = Bauchwassersucht, Wasserbauch

- Als Aszites bezeichnet man eine pathologische Ansammlung von freier Flüssigkeit in der Bauchhöhle, genauer gesagt der Peritonealhöhle. Der Begriff wird sowohl für das Krankheitsbild als auch für die Flüssigkeit verwendet.
- KU: Fluktuationswelle, Flankendämpfung (Änderung der Dämpfung bei Lagewechsel)
- Diagnostische Punktion (Parazentese)
- Ursache des Aszites ist immer der Austritt von Flüssigkeit aus Blutgefäßen in die Bauchhöhle.
- Man unterscheidet folgende Ursachen bzw. Typen von Aszites:
    - nicht-entzündlicher Aszites: Transsudat bei portaler Hypertension (z.B. bei Leberzirrhose), Herzinsuffizienz, erniedrigtem kolloidosmotischen Druck (Hypoalbuminämie, nephrotisches Syndrom), exsudativer Enteropathie, Magenkarzinom, Kolonkarzinom
    - entzündlicher Aszites: Exsudat (bei Tumor oder Entzündung, z.B. Spontan bakterielle Peritonitis, Peritonealkarzinose)
    - hämorrhagischer Aszites: bei tuberkulöser Peritonitis, Peritonealkarzinose, nach Ruptur eines Gefäßes (Blutung in die Bauchhöhle hinein)
    - chylöser Aszites: Austritt von Lymphflüssigkeit bei Abflussstörung im Ductus thoracicus
    - biliärer Aszites: Gallige Peritonitis

Was ist Manchester-Triage-System?

- Beim Manchester-Triage-System, kurz MTS, handelt es sich um ein Sichtungsverfahren, das primär im Bereich von Notaufnahmen verwendet wird. Anhand einfacher Kriterien werden die Patienten in 5 Gruppen - je nach ihrer Behandlungspriorität - eingeteilt.
- Sofort - rot, sehr dringend - orange, dringend - gelb, normal - grün, nicht dringend – blau

DRINGLICHKEITSSTUFEN IM MTS				
Ziffer	Name	Farbe	Max. Zeit	Kontrolleinschätzung spätestens nach
1	Sofort	Rot	0 Minuten	
2	Sehr dringend	Orange	10 Minuten	10 Minuten
3	Dringend	Gelb	30 Minuten	30 Minuten
4	Normal	Grün	90 Minuten	90 Minuten
5	Nicht dringend	Blau	120 Minuten	120 Minuten

Was sind die klinischen/laborchemischen Zeichen eines Stillikterus? Ein Muttermilchikterus ist eine Sonderform der Neugeborenengelbsucht ohne Hämolyse, die bei gestillten Säuglingen auftreten kann. Abgesehen von der Erhöhung des Bilirubinspiegels entwickeln sich die Säuglinge jedoch gut und zeigen keine weiteren Symptome.

- Früher Muttermilchikterus ("early onset breastfeeding jaundice"): in den ersten Tagen, wenn ein Säugling zu wenig gestillt wird bzw. die durch die Muttermilch zugeführte Kalorienmenge nicht ausreichend ist.
- Später Muttermilchikterus ("late onset breastfeeding jaundice"): in der 2. Lebenswoche, durch die Zusammensetzung der Muttermilch, was zu einer Hemmung der Konjugation des Bilirubins führt.

Wie ist die Notfallmedizin in Ihrem HL organisiert? Unterschied zu DL?

Was bedeutet "ins kalte Wasser werfen"? Schwierige Aufgaben an Laien und Unerfahrenen

Was ist green Energy?

Was ist chronische Gastritis? Wie können Sie sie feststellen? Anamnese + Gastroskopie (Probeexzision)

10

Welche Symptome weisen Patienten mit Kolorektal-CA beim Stuhlgang auf? Obstipation/ rektaler Blutabgang/ paradoxe Diarhhoe/ ungewollter Stuhlabgang bei Flatus (falscher Freund) / Bleistiftstuhl

Was ist Raucherbein?

Was macht PEI und mit wem arbeitet PEI? Paul-Ehrlich-Institut ist eine Einrichtung des Bundesministeriums für Gesundheit. Es ist das deutsche Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel.

Silber-/Goldenhochzeit?

Arten von Impfung?

- Lebendimpfstoffe: abgeschwächter Krankheitserreger
- Totimpfstoffe: abgetötet bzw. inaktiviert
- mRNA-Impfstoff
- Vektorimpfstoff

Unterschied zwischen anaphylaktischem Schock und Allergie?

Wie können Sie den Pat. beruhigen?

Wofür ist WHO zuständig? bekämpfung von Erkrankungen, insbesondere Infektionskrankheiten und die Förderung der allgemeinen Gesundheit aller Menschen weltweit

ERCP-Komplikationen? Brauchen Sie eine schriftliche Bestätigung?

Die häufigste Ursache von Synkope in älteren Menschen? Hyponatriämie, weil sie immer Diuretika einnehmen, welche die Hyponatriämie verursachen können.

Welche Organe sind schlecht betroffen bei Fahrradunfall bei Kindern? Pankreas, Milz und Leber

Pankreatitis

= eine Entzündung des Pankreas (Bauchspeicheldrüse)

- **Akute Pankreatitis**
  - <u>Ätiologie</u>: biliäre Genese (**Choledocholithiasis**, Gallengangsstenose), **Alkoholabusus**, **Hypertriglyzeridämie**, idiopathisch, Bauchtrauma, Infektionen (Mumps, HIV, Parasiten), Medikamente (Östrogene, Glukokortikoide), Autoimmun (SLE oder Sjögren-Syndroms)
  - <u>Symptome</u>: epigastrischen **gürtelförmigen** Dauerschmerz mit Ausstrahlung in den Rücken, Nausea, Emesis, Meteorismus, paralytischen Ileus, Tachykardie, Hypotonie, Fieber, Aszites, Ikterus, dunklere Urin, helle Stuhl
  - <u>Diagnostik</u>:
    - KU: reduzierter AZ,
      - Abwehrspannung (Gummibauch)

        - Grey-Turner-Zeichen = grünlich Hautveränderung an den Flanken (Ekchymosen), Cullen-Zeichen = " um den Nabel ❑ Nekrotisierende Verlauf
    - Labor: erhöhte **Lipase**, Amylase, Cholestase-Parameter +/- Hyperglykämie
    - Abdo-**Sonographie**
    - MRCP
    - Abdo-CT bei Verdacht auf Komplikationen
  - Komplikationen: Hypovolämischer Schock, Abszess, Pseudozysten, Nekrose, Chronifizierung
  - Therapie:
    - Konservativ: Volumen- Elektrolytsubstitution (Ringer-Laktat-Infusion), Nulldiät (keine Feste Nahrungsmittel), Analgetikum, Plasmapherese (bei Hypertriglyzeridämie über 1000 mg/dl), Antibiotikum (Carbapenem, Ceftriaxon, Metroidazol), PPI
    - Interventionelle: endoskopische Drainage / Spülung / Resektion der Nekrosen +/- ERCP

- **Chronische Pankreatitis**
  - Ätiologie: Alkoholabusus +/- Tabakrauchen, Hypertriglyzeridämie, primärer Hyperparathyreoidismus mit Hyperkalzämie
  - Pathophysiologie: die Aktivierung der proteolytischen Pankreasenzyme, die zu einer Autodigestion des Organs ❑ Kalzifikation
  - Symptome:
    - starker, nicht kolikartiger Schmerz, gürtelförmig, beidseitig ausstrahlend, rezidivierend
    - durch Maldigestion: **Gewichtsverlust**, **Steatorrhö**, Meteorismus, Diarrhö, Flatulenz
    - diabetische Stoffwechselzustände bei endokriner Pankreasinsuffizienz
    - Ikterus
  - Diagnostik:
    - Labor: **Hypokalzämie**, erhöhte Tumormarker (**CEA**), ggf. verminderte Komplementfaktoren (C3, C4), **Elastase-1 im Stuhl** (< 100 µg = exokrine Pankreasinsuffizienz)
    - **Abdo-Sonographie**: Zeichen einer chronischen = Verkalkungen, Pankreaspseudozysten ❑ deuten eher auf eine alkoholische Pankreatitis
  - Komplikationen: Fistelbildungen, Pseudozysten, Pankreaskarzinom
  - Therapie: gleich mit akute + antidiabetische Therapie bei einer endokrinen Pankreasinsuffizienz / Pankreatin bei exokrine Pankreasinuffizienz
    - Operative: duodenumerhaltende Pankreaskopfresektion (= Whipple-Operation)

13. Choledocholithiasis s.110

Arzt-Patient-Gespräch

-Name, Geburtsdatum, Gewicht, Größe

- Rose-Marie Hagen
- 59 J.
- *01.01.1963: ich wurde am 1. Tag des Jahres 1963 geboren
- 1,65 m
- 71,3 kg

-Hauptbeschwerde

Patientin

Martin Bräker
50J.

* 17.08.1974
1,94 cm 92 kg

Pankreatitis

Hauptbeschwerden

- seit gestern Abend bestehende, plötzlich aufgetretene, persistierende, progrediente, ziehende Oberbauchschmerzen
- Auslöser: nach dem Verzehr von Spiegeleier und Brattkartoffel
- Die Schmerzintensität: 6/10 auf der Schmerzskala gestern Abend
  4/10 auf der Schmerzskala aktuell
- Ausstrahlung: in den Rücken
- ~~Vor~~ verstärkende Faktoren: Ø
- lindernde Faktoren: Ibuprofen 400 mg 2 Tablet einmal ein bisschen geholfen

Begleitsymptome

- Fieber (38,9°C gestern, 38,3°C heute 2, oral)
- Nachtschweiß seit gestern
- Schüttelfrost seit gestern
- Durchfall (glänzend, hellbraun klebrig, sauer, ohne Blut extrem riecht)
- Übelkeit seit gestern
- Erbrechen (1 Mal, heute Morgen, unverdautes Essen, ohne Blut)

~~Weg~~ vegetative Anamnese

- Inappetenz
- schmerzbedingte Schlafstörung

Vorerkrankungen

- Hyperlipidämie seit 5 Jahren
- altT seit 5 Jahren
- Morbus Meniere seit 10 Jahren (letzte Attack vor 2 Jahren)

OPs

- Tonsillektomi mit 8. Lj.
- Appendektomi mit 18. Lj.

Medikamente

- Candesartan 16 mg (0-0-1)
- Simvastatin 40 mg (0-0-1)
- Parasetamol 400 mg b.B.

Allergien / Unverträglichkeiten

Heuschnupfen in der Kindheit (Eigenblutthera.)

Genussmittel

Nikotinkonsum: Exraucher (ca 5 py.)
Alkoholkonsum: 2-3 Gläser Wein od. Rotwein täglich seit langer Zeit
Drogenkonsum: wurde verneint

Familienanamnese

Vater: MI vor 2 Jahren, aHT
Mutter: DM Typ II
Bruder: Ulcus ventriculi - OP

Sozialanamnese

- Beruf: Priester
- ledig
- keine Kinder
- wohnt allein

Verdachtsdiagnose

akute Pankreatitis

Differentialdiagnose

- Cholangitis
- Gastroenteritis
- Ulcus ventriculi

weitere Procedere

- KW
- Vitalparameter, EKG
- Labor: gr. BB, Entzündungsparameter, Nierenwerte, Leberwerte, Elektrolytwerte, Cholestasewerte (GGT, ALP, Bili), Amylase, Lipase, Elastase 1 im Stuhl, Lipid Profil, B2
- Sonographie Abdomen
- ggf. MRCP CT Abdomen
- gastroenterologisches Konsil

Therapie

- stationäre Aufnahme
- Nahrungskarenz
- Flüssigkeitszufuhr
- Elektrolytsubstitution
- Analgetikum
- PPI
- Antiemetikum
- Antipyretikum
- Alkoholkarenz
- bei nekrotisierender Pankreatitis Antibiotika
- bei biliärer Genese ERCP

Das hängt von den Ergebnissen ab.

"Im EKG misst die elektrische Aktivität Ihres Herzens."

✓ Eine Hypokalzämie weist auf eine ausgeprägte Fettgewebsnekrose hin, und ein erhöhter Hämatokrit zeigt eine Hämokonzentration durch Volumenmangel an – beide sind Zeichen einer schweren akuten Pankreatitis mit ungünstiger Prognose
olumsuz

✓ Das Grey Turner, Cullen Zeichen und Fox Zeichen sind Hautverfärbung, die auf eine retro ~~und~~ oder intraperitoneale Blutung hinweisen, typischerweise bei schwerer hämorrhagischer Pankreatitis

✓ Bei intraperitonealen Organerkrankungen sehen wir eine Abwehrspannung, bei retroperitonealen Organerkrankungen kann es zum Gummibauch kommen

Perforation im Magenbereich oder, kann sonst rechts oberes Sektor, (Appendicitis, perfore ulser)

kann yumuşak ~~veya~~ gergin. Retroperitoneal dolayısıyla intraabdomen ve sonuçta gerilir

Zu den ~~[illegible]~~ retroperitonealen Organen gehören unter anderem die Nieren, Nebennieren, der größte Teil des Pankreas, das Duodenum sowie das Colon ascendens und descendens

✓ CT wird bei akuter Pankreatitis nicht sofort routinemäßig durchgeführt, sondern erst bei unklarem Verlauf, Verschlechterung oder zum Nachweis von Komplikationen meist nach 48-72 Stunden.

✓ Die Endosonographie ist eine Kombination aus Endoskopie und Ultraschall, bei der innere Organe von innen mit hoher Auflösung dargestellt ~~wird~~ wird.

✓ Eine ERCP wird bei akuter Pankreatitis nur durchgeführt bei Verdacht auf Cholangitis oder anhaltender biliärer Obstruktion, nicht routinemäßig

Steatorrhoe → überriechend, glänzend, öl

Danisch

Warum legen wir Magensonde?

Es gibt Risiko für Akutes Abdomen
bei Verdacht auf Akutem Abdomen legen wir Magensonde

Morbus Meniere: Das ist eine Erkrankung des Gleichgewichts und Hörorgans im Innenohr, die Schwindelanfälle, Hörprobleme und Ohrgeräusche verursacht.

Pankreatitis Prognose

Wichtige Prognoseparameter bei akuter Pankreatitis sind klinische Zeichen der Organinsuffizienz, erhöhte Entzündungsparameter (CRP↑) Hämokonzentration (Hkt ↑ dasmegen), Nierenfunktionsstörung (Kreatinin↑) und das Ausmaß (150<) der Nekrose im CT

Kalzium ↓ ⟹ weist auf Fettnekrose hin

Ranson-Score schätzt die Schwere der akuten Pankreatitis anhand von Anfangs und 48 Stunden.

BISAP dient der frühen Risikoeinschätzung innerhalb der ersten 24 Stunden

APACHE II ist ein allgemeiner Intensivscore zur Beurteilung der Krankheitsschwere

Ranson Score (11 Kriterien)

Alter > 55 Jahre
Leukozyten > 16.000/µl
Blutzucker > 200 mg/dl
LDH > 350 U/L
AST (GOT) > 250 U/L

Nach 48 Stden

Hämatokritabfall > 10%
Harnstoffanstieg (BUN) 5 mg/dl <
Serumkalzium 8 mg/dl >
PaO_2 < 60 mmHg
Basendefizit 4 mmol/L
Flüssigkeitsbedarf > 6 L

BISAP Score

BUN > 25 mg/dl
Bewusstseinsstörungen (GCS < 15)
SIRS vorhanden
Alter > 60 Jahre
Pleuraerguss im Bild

GCS (Glasgow Koma Skala)

Augenöffnung (E) (1-4)
Verbale Reaktion (V) (1-5)
Motorische Reaktion (M) (1-6)

Total Score
3-15

13-15 → Hohe
9-12 → Orta
8> → AGV

Der Glasgow-Coma-Score beurteilt den Bewusstseinszustand anhand von Augenöffnung, verbaler und motorischer Reaktion